



REVISIÓN

Rol de las enfermeras en el cuidado espiritual a los pacientes y sus familias en las unidades de cuidado intensivo: una revisión de alcance

María Kappes (RN, MSc)^{a,*}, Carlos Alberto Fernández-Silva (RN, MSc)^b,
Lucía Catalán (RN, MSc)^c, Constanza Navalle (RN)^a,
Moisés Díaz (RN)^a e Ivan Guglielmi (RN, MSc)^d

^a Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud, Escuela de Enfermería, Universidad San Sebastián, Puerto Montt, Chile

^b Universidad de Los Lagos, Campus Puerto Montt, Puerto Montt, Chile

^c Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud, Escuela de Enfermería, Universidad San Sebastián, Santiago, Chile

^d Centro Puentes de Investigación en Salud, Universidad de Aysén, Aysén, Chile

Recibido el 13 de diciembre de 2023; aceptado el 6 de abril de 2024

Disponible en Internet el 23 julio 2024

PALABRAS CLAVE

Atención de
enfermería;
Espiritualidad;
Unidades de cuidados
intensivos

Resumen

Introducción: Los pacientes críticamente enfermos y sus familias se benefician del cuidado espiritual. Existe poca evidencia de cómo se desarrollan los cuidados espirituales en las unidades de cuidado intensivo (UCI).

Objetivo: El objetivo de esta revisión fue determinar la forma en que las enfermeras incluyen los cuidados espirituales a pacientes y familias en las UCI.

Metodología: Se realizó una revisión de alcance, con guía de la metodología de Johanna Briggs Institut y reporte de resultados con la guía PRISMA-ScR entre marzo a abril de 2023. Se consultaron las bases de datos: Pubmed, Scopus de Elsevier, Web of Science (WOS) y del motor de búsqueda Ebsco, con Medline Complete, Cinhal y Academic Search Ultimate con las palabras clave: *Nursing care, ICU, spirituality*. Se incluyeron artículos con enfoque cualitativo y cuantitativo de cualquier diseño que describieran la espiritualidad en los cuidados de enfermería a pacientes o familias en las UCI, excluyendo editoriales y cartas al editor. Los límites fueron los años 2015-2023, sin límites de idioma.

Resultados: Se recuperaron 319 artículos, luego de eliminar duplicados, aplicar criterios de inclusión y lectura crítica se incluyen 11 estudios, 6 con enfoque cuantitativo y 5 con enfoque cualitativo. Se describen condiciones para el cuidado espiritual donde destaca la necesidad de un espacio físico y condiciones de las enfermeras como motivación y empatía. Existen barreras personales, organizacionales y del equipo de trabajo para el cuidado espiritual. Se describen facilitadores para el cuidado espiritual como la preparación, comunicación y la presencia de capellanes.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: maria.kappes@uss.cl (M. Kappes).

<https://doi.org/10.1016/j.enfi.2024.04.006>

1130-2399/© 2024 Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Se reservan todos los derechos, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

Conclusiones: Las enfermeras en las UCI disponen de muchas formas de entregar cuidados espirituales a los pacientes y sus familias. Estas se deben desarrollar teniendo en cuenta las barreras de espacio físico, personales, organizacionales y del equipo de trabajo.

© 2024 Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Se reservan todos los derechos, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

KEYWORDS

Nursing care;
Spirituality;
Intensive care units

Nurses' role in spiritual care for patients and families in intensive care units: A scoping review

Abstract

Introduction: Critically ill patients and their families benefit from spiritual care. There is limited evidence on how spiritual care is delivered in Intensive Care Units (ICUs).

Aim: The objective of this review was to determine how nurses include spiritual care for patients and families in ICUs.

Methodology: A scoping review was conducted following the Joanna Briggs Institute methodology guidelines, with results reported using the PRISMA-ScR guidelines from March to April 2023. PubMed, Scopus by Elsevier, Web of Science (WOS), and the Ebsco search engine were consulted, including databases such as Medline Complete, Cinhal, and Academic Search Ultimate using the keywords Nursing care, ICU, spirituality. Articles with qualitative and quantitative approaches of any design describing spirituality in nursing care for patients or families in ICUs were included, excluding editorials and letters to the editor. The time frame ranged from 2015 to 2023, with no language restrictions.

Results: A total of 319 articles were retrieved, after removing duplicates and applying inclusion criteria with critical reading, 11 studies were included, 6 with a quantitative approach and 5 with a qualitative approach. Conditions for spiritual care are described highlighting the need for physical space and nurse-related conditions such as motivation and empathy. Personal, organizational, and team-related barriers to spiritual care exist. Facilitators for spiritual care are described such as preparation, communication, and the presence of chaplains.

Conclusions: Nurses in ICUs have various ways to provide spiritual care to patients and families. These must be developed considering barriers such as physical space, personal, organizational, and team-related challenges.

© 2024 Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC). Published by Elsevier España, S.L.U. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

Introducción

El cuidado que brindan las enfermeras en las unidades de cuidados intensivos (UCI) es complejo, y debe centrarse en el paciente. Se espera que este cuidado sea holístico y contemple aspectos espirituales a los pacientes y sus familias que pasan por un problema de salud grave¹. Las ventajas de incorporar el cuidado espiritual son muchas: satisfacción de los pacientes, sus familias² y el bienestar a las enfermeras al percibir que entregan cuidados integrales^{3,4}.

No hay suficiente consenso en cuanto a la definición de cuidados espirituales y espiritualidad ya que varía ampliamente de una cultura y de un país a otro⁵. Los cuidados espirituales han sido definidos por Van Leeuwen et al. como el cuidado que reconoce y responde al espíritu humano cuando se enfrenta a eventos que cambian la vida o tristeza, y puede incluir la necesidad de significado, de autoestima, de expresarse, de apoyo a la fe, tal vez para ritos, oración o sacramento, o simplemente para un oyente sensible⁶. Por

otra parte, para esta revisión se adoptó la definición de Burkhardt y Hogan de espiritualidad. Se define como la búsqueda de significado y propósito en la vida, así como las interconexiones compartidas con el mundo, un «poder superior» y otras personas que comparten este mundo, y que puede implicar una trascendencia a un nivel superior del ser⁷. Si bien estas definiciones pueden ser orientadoras, no está del todo claro como las enfermeras pueden ejecutar estos cuidados, considerando el entorno de las UCI, la gravedad de los pacientes, las preferencias de los familiares y la fuerte carga laboral. Con todo ello, cuando se ha preguntado a los pacientes y sus familias estos siempre expresan la necesidad de cuidados espirituales por parte de las enfermeras^{8,9}. También, las propias enfermeras reconocen que pueden brindar estos cuidados mientras están realizando labores asistenciales a sus pacientes⁸. A pesar de esto, sabemos que existen barreras que no permiten que los pacientes o sus familias reciban todos los aspectos del cuidado espiritual que esperan. Se han descrito factores personales de las enfermeras

como la falta de propias creencias o factores de las propias UCI como la sobrecarga de labores asistenciales¹⁰. Otro aspecto es que muchas UCI no cuentan con un espacio físico que permita la visita de un capellán u otro asistente espiritual que se pueda entrevistar con la familia. Un espacio físico privado y una atmósfera especial permite además el resguardo y la privacidad que los familiares pueden necesitar para expresar sus dudas y emociones^{5,11}. Otro aspecto importante en las UCI neonatales está dado por la necesidad de apoyo a los padres y madres por parte de las enfermeras. Este apoyo permite a los padres y madres participar del cuidado de sus hijos/as lo que ha demostrado acortar el tiempo al alta¹².

Muchas de las interrogantes que tenemos hoy acerca de los cuidados espirituales en las UCI quedaron manifiestas durante la pandemia de COVID-19. Esto, ya que la restricción de visitas, la alta demanda en las UCI y mortalidad asociada pusieron una gran tensión en este tema¹³. De esta forma, los pacientes tuvieron pocas oportunidades de tener el consuelo de sus familias, esto provocó también que las enfermeras generen nuevas estrategias para mantener el nexo y cariño familiar^{14,15}.

Si bien se ha realizado investigación para medir, con diversos instrumentos, la dimensión de cuidados espirituales en las UCI¹⁶, no hay consenso acerca de la forma y condiciones en que las enfermeras realizan estos cuidados a los pacientes y sus familias en las UCI.

Objetivo

El objetivo de este estudio fue determinar la forma en que las enfermeras incluyen los cuidados espirituales a los pacientes y sus familias en las UCI.

Metodología

Diseño

Se diseñó una revisión de alcance (*Scoping review*), según la metodología propuesta por Peters et al.¹⁷ de Johanna Briggs Institut¹⁸. Para ello se siguieron los pasos de identificar una pregunta de investigación, elaborar una estrategia de búsqueda, identificación de estudios, selección de estudios, extracción de los datos y elaboración de síntesis de los resultados.

La pregunta de investigación elaborada fue: ¿Qué condiciones existen para que las enfermeras incluyan los cuidados espirituales a pacientes y familias en las UCI? Se utilizó la definición de espiritualidad de Burkhart et al.⁷. El protocolo de esta revisión de alcance se registró en OSF¹⁹.

Estrategia de búsqueda

Se realizó una búsqueda desde marzo a abril de 2023 en las bases de datos: Pubmed, Scopus de Elsevier, Web of Science (WOS) y del motor de búsqueda Ebsco, con Medline Complete, Cinhal y Academic Search Ultimate con las palabras claves ((nursing care) AND (ICU)) AND (Spirituality). Los límites que se establecieron para la búsqueda fueron años 2015-2023. Se establecieron estos límites para que esta revisión

entregue una versión actualizada del estado del arte, teniendo en cuenta que la humanización del cuidado como corriente teórica es más reciente²⁰. No se establecieron límites de idioma. Paralelamente se realizó una búsqueda de literatura gris en repositorios de universidades y resúmenes de congresos de enfermería.

Selección de artículos

Para la selección de artículos se utilizó como criterio de inclusión: cualquier artículo (todo tipo de diseño), que describa las condiciones para la provisión de cuidados espirituales (a pacientes o familias) en las UCI. Se excluyeron editoriales y cartas al editor.

Para el reporte de los resultados se utilizó la guía PRISMA-ScR²¹. Los estudios identificados fueron ingresados al gestor bibliográfico Mendeley donde como primer paso se eliminaron los duplicados. Para la selección de los artículos dos investigadores en forma independiente aplicaron el criterio de inclusión leyendo el título y *abstract* de los artículos. Las diferencias fueron resueltas con un tercer investigador.

Extracción de los datos

Dos investigadores en forma independiente analizan el texto completo para decidir su inclusión en la revisión. Se construyó con los artículos seleccionados una planilla Excel® que contempla los datos de cada estudio: autores, título del estudio, país, año de publicación, diseño del estudio, participantes o muestra y principales resultados.

Síntesis de los resultados

La síntesis de los resultados se presenta de forma narrativa debido a la heterogeneidad de los diseños de estudios incluidos en esta revisión. Los resultados fueron discutidos por los autores para responder al objetivo de esta revisión de alcance.

Resultados

La búsqueda inicial permitió identificar 319 estudios. Luego de eliminar duplicados, 307 estudios fueron revisados leyendo el título y resumen. De ellos, 57 estudios fueron seleccionados para lectura completa. Se eliminan 46 estudios por no tener intervenciones o descripción de cuidados espirituales a pacientes o familias en las UCI, o porque las intervenciones no están desarrolladas, guiadas o lideradas por enfermeras, o no son desarrollados en las UCI. Son incluidos en esta revisión 6 estudios con enfoque cuantitativo y 5 estudios con enfoque cualitativo (fig. 1).

Los estudios fueron desarrollados en diferentes países: un estudio en Irán (9,09%), un estudio en EE. UU. (9,09%), 2 estudios en Canadá (18,18%), 2 estudios en Turquía (18,18%), un estudio en Sudáfrica (9,09%), un estudio en Irlanda (9,09%), 2 estudios en Holanda (18,18%) y un estudio en España (9,09%). De los estudios seleccionados 7 de ellos (63,63%) no mencionan el tipo de UCI donde se realizó el estudio. Dos (18,18%) fueron realizados en las UCI de adulto y 2 (16,6%) en las UCI neonatal o pediátrica. Los partici-

Tabla 1 Resultados de los artículos

Autor	Título	País	año	Diseño del estudio	Participantes/muestra	Principales resultados
Coughlin, K. et al.	Characterization of Spirituality in Maternal-Child Caregivers	EE. UU.	2017	Cuantitativo, descriptivo	406 enfermeras y médicos cuidados intensivos neonatales	- La mayoría de los participantes se declaran cristianos y con una amplia gama de creencias espirituales. - Mientras mayor es la propia identificación con espiritualidad, mayor es la conciencia de proporcionar cuidados espirituales a los pacientes.
Bone, N. et al.	Critical Care Nurses Experiences with spiritual care: The Spirit Study	Canada	2018	Cualitativo, descriptivo	25 enfermeras unidad de cuidados intensivos	- Los capellanes presentes en la unidad de cuidado intensivo pueden brindar apoyo a pacientes y también a médicos y enfermeras, luego de la pérdida de un paciente. - El cuidado espiritual proporciona bienestar al sentir que se entrega un cuidado holístico. - Las enfermeras se reconfortan cuando pueden proporcionar tiempo a la familia para despedirse del paciente o tocarlo. - Parte de los cuidados que se valoran son: proporcionar a la familia la oportunidad de llorar, acompañar o escucharlos. También proporcionar comodidad con sillas, pañuelos o un vaso de agua.
Roze des Ordon, A. et al.	Exploring spiritual health practitioners' roles and activities in critical care contexts	Canadá	2022	Cualitativo, descriptivo	Médicos, profesionales que brindan cuidados espirituales, familiares de pacientes en las UCI	- Los cuidados espirituales se centran en acompañar, asesorar, facilitar conversación y toma de decisiones en el contexto de pacientes graves. - Se producen tensiones entre los diferentes roles que se cumplen para proporcionar cuidados espirituales. - El acompañamiento requiere de reflexión personal y empatía. Para brindar consejería se requiere además confianza y simpatía. Para honrar a un paciente con la familia se requiere involucrarse, conocer al paciente a través de la familia. Para apoyar en la toma de decisiones difíciles se requiere iniciar el diálogo y ser capaz de mediar en los conflictos que se producen.
Rahman, S. et al	Factors that predict the perception of spirituality and spiritual care of nurses working in high-risk units and the effect of death anxiety	Turquía	2020	Cuantitativo, descriptivo	382 enfermeras de las UCI y departamentos de emergencia	- La mayoría está de acuerdo con que las enfermeras pueden entregar cuidados espirituales mientras hacen el cuidado habitual de sus pacientes. - No existe una definición explícita o común acerca de cuidado espiritual para las enfermeras. - Mientras mayor es la satisfacción de las enfermeras, más se explica la posibilidad de brindar cuidados espirituales.

Tabla 1 (continuación)

Autor	Título	País	año	Diseño del estudio	Participantes/muestra	Principales resultados
Zambesi, M. et al.	Spiritual Care: A Description of Family Members' Preferences of Spiritual Care Nursing Practices in Intensive Care Units in a Private Hospital in Kwa-Zulu Natal, South Africa	Sudáfrica	2022	Cuantitativo, descriptivo	47 familiares de pacientes en las UCI	- Las familias de pacientes en las UCI valoran de las enfermeras: que se les proporcione momentos de tranquilidad, distracción (p. ej., a través de la risa o el arte), conversar acerca del sentido de la vida y ofrecer hablar acerca de meditación. - La mayoría de los encuestados eran cristianos, pero solo un 19,1% estuvo fuertemente de acuerdo en la solicitud de un capellán. - Hay una fuerte preferencia de los familiares que las enfermeras brinden atención espiritual en los pacientes en las UCI.
Caulfield, F. et al.	Spiritual care in neonatology: Analysis of emergency baptisms in an Irish neonatal unit over 15 years	Irlanda	2018	Cualitativo, retrospectivo	354 neonatos de las UCI	- Los bautismos de urgencia realizados en neonatos de las UCI para aumentar la esperanza de vida, eran más efectivos aquellos efectuados por sacerdotes cristianos, que los bautismos hechos por profesionales de salud. - Se debe orientar a los familiares de los pacientes sobre las posibilidades de rituales o ceremonias no cristianas para las distintas religiones profesadas.
Willemse, S. et al.	Spiritual Care in the ICU: Perspectives of Dutch Intensivists, ICU Nurses, and Spiritual Caregivers	Países Bajos	2017	Cuantitativo, descriptivo.	99 intensivistas, 290 enfermeras de las UCI y 98 cuidadores espirituales.	- La mayoría de los encuestados concordaban en que la filosofía de la vida y la espiritualidad de los pacientes son importantes para enfrentar procesos patológicos. - La mayoría de los pacientes y sus familias, en primera instancia rechazaron los cuidados espirituales por percibir que no era necesario o por falta de educación y comunicación del personal de salud. - El personal sanitario consideró muy importante el trabajo multidisciplinario para entregar cuidados espirituales, aunque la falta de tiempo y la complejidad de cada paciente dificultan su inclusión.
Bulut, T. et al.	The effects of spiritual care intervention on spiritual well-being, loneliness, hope and life satisfaction of intensive care unit patients	Turquía	2023	Cuantitativo, diseño experimental	64 pacientes aleatorizados en 32 al grupo intervenido (8 sesiones de intervención por enfermera basado en modelo de cuidado espiritual) y 32 al grupo control (atención habitual de enfermería)	- El grupo intervenido tuvo efectos positivos en cuanto a bienestar espiritual, soledad, esperanza y satisfacción con la vida. - En el ambiente de las UCI donde los pacientes se sienten solos y distanciados de su vida habitual, el soporte espiritual entregado por enfermeras es importante y valorado. - La esperanza es especialmente importante para pacientes gravemente enfermos. La intervención de cuidado espiritual logra aumentar la esperanza de los pacientes en las UCI.

Tabla 1 (continuación)

Autor	Título	País	año	Diseño del estudio	Participantes/muestra	Principales resultados
Noome, M. et al.	The role of ICU nurses in the spiritual aspects of end-of-life care in the ICU: An explorative study	Países Bajos	2016	Cualitativo, descriptivo	11 capellanes	- Los capellanes describen el papel que cumplen las enfermeras en las UCI en cuanto a cuidados espirituales. - Los aspectos principales que surgen de esta investigación son: concientización de las enfermeras de la UCI, comunicación, intervenciones de enfermería, atención multidisciplinaria y educación sobre los aspectos espirituales. - El autoconocimiento de las enfermeras es importante para poder brindar apoyo a otros. - La comunicación surge como una herramienta esencial de comunicación honesta con los pacientes y la familia al brindar cuidados espirituales. - Las enfermeras tienen una gran oportunidad de cercanía y de brindar apoyo espiritual a pacientes y familia en las UCI.
De Diego-Cordero, R. et al.	Spiritual needs during COVID-19 pandemic in the perceptions of Spanish emergency critical care health professionals	España	2023	Cualitativo, exploratorio y observacional	47 enfermeras, 2 auxiliar de enfermería	- La mayoría de las enfermeras de urgencias y cuidados críticos creen que la atención espiritual es importante para la práctica clínica. - Entre las barreras más comunes para abordar las necesidades espirituales se mencionan la carga de trabajo, la falta de capacitación, el miedo a imponer sus propias creencias, la falta de tiempo, la falta de motivación y la privacidad del paciente. - Cómo recurso para el abordaje de la espiritualidad en urgencias y cuidados críticos, se señala la necesidad de tiempos y lugares que permitan el acercamiento espiritual y la disponibilidad de personal especializado, cómo guías espirituales que abarquen varias religiones.
Elham, H. et al.	The effect of need-based Spiritual/Religious intervención on spiritual well-being and anxiety of elderly people	Irán	2015	Cuasi experimental con diseño de grupo de control previo y posterior a la intervención (sesiones de 60-90 min de espiritualidad)	66 pacientes de 60 años o más con cualquier diagnóstico de enfermedad cardiovascular. Confirmado ingresado en la unidad de cuidados coronarios	- La mayoría de los pacientes declaran que orar les daba más poder para afrontar su enfermedad y, finalmente la muerte. - Se encontraron diferencias estadísticas significativas entre las puntuaciones medias de ansiedad T y ansiedad S del grupo de intervención. Sin embargo, no se encontraron estas diferencias en el grupo de control. - Existe una correlación negativa entre espiritualidad y la ansiedad.

UCI: unidad de cuidados intensivos.

Fuente: elaboración propia.

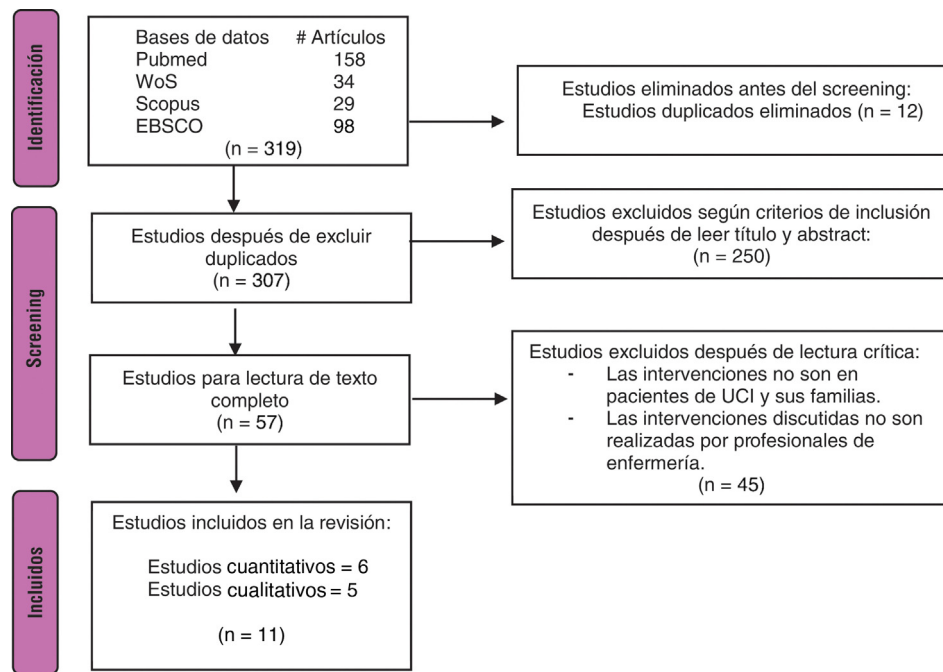


Figura 1 Diagrama PRISMA para selección de estudios incluidos (Tricco et al.²¹, 2018).

pantes de los estudios incluyen enfermeras, médicos, otros profesionales o personas que brindan cuidados espirituales, familiares y pacientes en las UCI (tabla 1).

Condiciones para efectuar cuidados espirituales en las UCI

Lo primero que podemos relevar en este estudio es que una condición importante es la existencia de un espacio físico adecuado para los cuidados espirituales en las UCI²². Esta condición responde a la necesidad de las familias para tener un lugar donde poder conversar, expresar sus emociones y preocupaciones distinta al lugar donde es atendido el paciente.

Otro aspecto importante es que para las enfermeras poder brindar cuidados espirituales y espacio para la oración produce satisfacción, al entregar un cuidado holístico. En el paciente, la oración proporciona el poder para enfrentar la enfermedad, y eventualmente, la muerte de una mejor forma³. Todos estos elementos influyen también en mejorar la satisfacción del paciente con la atención brindada²³. Además, la oración y otras formas de espiritualidad son importantes ya que disminuyen la ansiedad en pacientes y familias²⁴.

Otra condición implícita al cuidado espiritual es el acompañamiento. Se ha establecido que para poder acompañar a un paciente se requiere reflexión personal, compasión y empatía²⁵.

Intervenciones enfermeras para el cuidado espiritual

Las intervenciones para el cuidado descritas son variadas. Pueden ser desarrolladas en forma paralela al cuidado

asistencial⁸. Incluyen que las enfermeras brinden el espacio para que pacientes y familiares puedan llorar, expresar sus temores. También acompañarlos y proporcionar un lugar físico, una silla, pañuelos o un vaso de agua³. Contemplan, además, que la enfermera sea capaz de guiar, asesorar en la toma de decisiones difíciles a la familia²⁵. Otra estrategia valorada por los familiares de pacientes en las UCI es la distracción, puede ser a través de música o arte. Estas estrategias pueden ser implementadas en salas de espera con música ambiental suave o muestras de algún tipo de arte²⁶.

Facilitadores para la entrega de cuidados espirituales

El primer facilitador que encontramos es que las enfermeras se encuentren dispuestas y preparadas para realizar cuidados espirituales²⁴. Por otro lado, que existan capellanes en las unidades hace que sea más factible el cuidado espiritual de pacientes y también al personal¹⁹, lo que haría que se sientan más satisfechos³, y con ello dispuestos a brindar cuidados integrales que incluyan la espiritualidad²⁵. Dentro de las herramientas que las enfermeras deben tener para mejorar su cuidado espiritual destaca la comunicación como la más relevante²⁶. Una buena comunicación facilita poder interpretar de forma correcta las necesidades del paciente y su familia, y también un acercamiento que es bien valorado frente a la soledad del paciente en las UCI²⁷.

Barreras para entregar cuidados espirituales

Se describen varios tipos de barreras que impiden o dificultan la entrega de cuidados espirituales por parte de las enfermeras en las UCI.

Barreras personales: Se han descrito varias barreras para que las enfermeras entreguen cuidado espiritual: la motivación y la empatía son necesarias para entregar cuidados espirituales al paciente²⁴.

Barreras organizacionales: Los salarios de las enfermeras¹⁰, el foco en procesos asistenciales y el exceso de carga de trabajo serían barreras que la propia organización pone sobre las enfermeras que dificultan que estas puedan brindar cuidados espirituales a pacientes y familias. También la falta de espacio físico es nombrada como una barrera²².

Barreras del equipo multidisciplinario: Las tensiones que se producen en el equipo son una barrera percibida para el cuidado espiritual²⁵, y también el que este cuidado sea entregado de forma multidisciplinaria, lo cual muchas veces no es posible por la falta de trabajo en equipo y el exceso de labores asistenciales²⁸.

Discusión

En este estudio se evidencia que la entrega de cuidados espirituales en las UCI por parte de las enfermeras es una labor compleja. La existencia de un espacio físico que permita a la familia comunicarse, expresar emociones, esperar, ser escuchados o acompañados por guías no existe en todas las UCI²⁹. En este sentido las propias enfermeras reconocen que una de las barreras para entregar cuidados espirituales es la privacidad del paciente²². Se entiende que los cubículos de paciente o cerca de la cama puede ser un lugar no adecuado por el ruido de las alarmas de los equipos, la presencia de otros familiares, etc.

Por otro lado, resulta necesario que las enfermeras cultiven habilidades específicas, entre las cuales se incluyen la comunicación y la empatía. Estas capacidades son esenciales, ya que el desarrollo de la propia espiritualidad no solo contribuye a un cuidado más integral, como se ha señalado en estudios previos²⁷, sino que también es fundamental para desempeñar efectivamente la función de cuidado. Sin embargo, es crucial destacar que el fomento de estas habilidades conlleva desafíos adicionales para las enfermeras que trabajan en las UCI, ya que se ha observado un aumento en la fatiga por compasión, como lo indica un metaanálisis reciente. Este análisis revela que los niveles más elevados de fatiga por compasión se registran en países asiáticos, mientras que los más bajos se encuentran en América y Europa³⁰.

Además, para el desarrollo de cuidados espirituales en las UCI se han descrito facilitadores y barreras. Entre las barreras personales destaca la falta de formación y el desarrollo de la propia espiritualidad. En este sentido, una investigación realizada en Brasil da cuenta de que los cuidados espirituales brindados dependen de las propias prácticas ya que no existe como contenido formal a las enfermeras en su formación³¹. Por ello, las propias competencias, conocimientos y prácticas de espiritualidad son importantes ya que mientras mayores son, más factible es que se brinden cuidados espirituales a los pacientes²⁷. Dentro de las barreras organizacionales lo que más destaca es que las enfermeras dedican mucho tiempo a las labores asistenciales y que las UCI es un servicio con gran carga laboral. Sin embargo, esta revisión evidencia que el estudio de Rahman et al.⁸ mostró que la mayoría de las enfermeras estuvieron de acuerdo con

que ciertos cuidados espirituales se pueden brindar mientras se realizan los cuidados asistenciales⁸. Por lo tanto, la intención de tocar al paciente, escucharlo o brindar un momento de reflexión no requiere muchas veces más que la voluntad de hacerlo.

En cuanto al equipo de trabajo, se producen tensiones que dificultan la entrega de cuidados espirituales²⁸. Estas tensiones probablemente puedan ser mejoradas por medio de la comunicación y el trabajo en equipo³². Como facilitadores para el cuidado espiritual destacan la identificación con la propia espiritualidad²⁶. Así la enfermera al tener un desarrollo de su propia espiritualidad es más factible que entregue cuidados espirituales a los pacientes y sus familias.

Una de las características de las UCI es que pacientes y familia se ven enfrentados a la toma de decisiones difíciles, y se espera que la enfermera pueda guiar, asesorar y acompañar^{12,26}. En el contexto de esta revisión, es relevante ya que la guía, el consuelo y el acompañamiento a la familia en estas decisiones son parte de los cuidados espirituales. Este tipo de estrategias ha sido analizado en una revisión de alcance que identifica las estrategias utilizadas por las enfermeras para la superación del duelo de los padres de las UCI pediátricas. Se evidencia la importancia de que los planes sean individualizados según la religión, etnia y necesidades individuales de los padres³³. En un ambiente tan complejo, las estrategias de distracción son bien valorada por pacientes y familiares. Al respecto una revisión sistemática con metaanálisis que revisó 11 estudios con 959 pacientes determinó que la musicoterapia disminuía el estrés y ansiedad de pacientes en las UCI³⁴.

En otra arista de los cuidados espirituales, también se realizan bautismos de urgencia dentro de las UCI³⁵, y se ha estudiado la presencia de capellanes u otros guías espirituales^{28,36}. La asistencia espiritual es fuertemente valorada por pacientes y familias, puesto que entregan esperanza³⁷ y disminuye la ansiedad²⁴.

El diferente contexto de países y religiones de esta revisión en las UCI de pacientes adultos, pediátricas y neonatales tiene como factor común que las enfermeras deben incluir siempre a la familia en sus cuidados espirituales. Varios estudios además recomiendan guías de otras religiones que permitan atender la diversidad de pacientes que podemos recibir^{22,35}.

Dentro de las limitaciones de esta revisión, es que se incluyeron todo tipo de estudios, con ello, existe gran heterogeneidad de condiciones en que se entregan los cuidados espirituales a los/as pacientes y sus familias en las UCI. En esta condición, puede que alguna variable no esté lo suficientemente representada en esta revisión.

Conclusiones

Para las enfermeras en las UCI se han descrito diversas estrategias para brindar cuidados espirituales de manera efectiva a los/as pacientes y sus familias. La implementación de estas estrategias se convierte en un desafío, considerando las diversas barreras que pueden surgir en el entorno hospitalario.

En primer lugar, la disponibilidad limitada de espacio físico en las UCI puede dificultar la prestación de cuidados espirituales adecuados. La disposición de las unidades

generalmente se enfoca en los cuidados asistenciales, lo que restringe el espacio y la privacidad para actividades espirituales. Se hace necesario adaptar entornos que favorezcan el cuidado espiritual, incluso dentro de las restricciones físicas inherentes a las UCI, con el fin de asegurar la provisión efectiva de cuidados espirituales.

Además, existen barreras personales que pueden influir en la provisión de cuidados espirituales. Las creencias individuales, la diversidad cultural y la falta de formación deben ser cuidadosamente consideradas para adaptar el enfoque espiritual de manera sensible y respetuosa.

Las barreras organizacionales también desempeñan un papel crucial en este contexto. La carga de trabajo, las políticas institucionales y la disponibilidad de recursos pueden afectar la capacidad de las enfermeras para dedicar tiempo y atención al cuidado espiritual. Es imperativa la creación de políticas hospitalarias que fomenten y respalden la inclusión del cuidado espiritual como parte integral del trabajo de las enfermeras en las UCI.

Por último, el trabajo en equipo también emerge como un factor esencial. La colaboración efectiva entre los profesionales de la salud, incluidos médicos, enfermeras y guías espirituales, es vital para superar las barreras y garantizar una atención espiritual cohesiva.

Financiación

Los autores declaran no haber recibido financiación para la realización de este trabajo.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Albaqawi HM, Butcon VR, Molina RR. Awareness of holistic care practices by intensive care nurses in north-western Saudi Arabia. *Saudi Med J*. 2017;38:826–31, <http://dx.doi.org/10.15537/smj.2017.8.20056>.
- Ho JQ, Nguyen CD, Lopes R, Ezeji-Okoye SC, Kuschner WG. Spiritual Care in the Intensive Care Unit: A Narrative Review. *J Intensive Care Med*. 2018;33:279–87, <http://dx.doi.org/10.1177/0885066617712677>.
- Bone N, Swinton M, Hoad N, Toledo F, Cook D. Critical Care Nurses' Experiences With Spiritual Care: The SPIRIT Study. *Am J Crit Care*. 2018;27:212–9, <http://dx.doi.org/10.4037/ajcc2018300>.
- Nazari R, Vanaki Z, Kermanshahi S, Hajizadeh E. "Where Withstanding is Difficult, and Deserting Even More": Head Nurses' Phenomenological Description of Intensive Care Units. *J Caring Sci*. 2016;5:133–43, <http://dx.doi.org/10.15171/jcs.2016.014>.
- Fournier AL. Creating a Sacred Space in the Intensive Care Unit at the End of Life. *Dimens Crit Care Nurs*. 2017;36:110–5, <http://dx.doi.org/10.1097/DCC.0000000000000231>.
- Van Leeuwen R, Attard J, Ross L, Boughey A, Giske T, Kleiven T, et al. The development of a consensus-based spiritual care education standard for undergraduate nursing and midwifery students: An educational mixed methods study. *J Adv Nurs*. 2021;77:973–86 [consultado 5 Nov 2023] Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.14613>
- Burkhart L, Hogan N. An Experiential Theory of Spiritual Care in Nursing Practice. *Qual Health Res*. 2008;18:928–38 [consultado 5 Nov 2023] Disponible en: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1049732308318027>
- Rahman S, Elbi H, Cakmakci Cetinkaya A, Altan S, Ozan E, Pirincci E. Factors that predict the perception of spirituality and spiritual care of nurses working in high-risk units and the effect of death anxiety. *Perspect Psychiatr Care*. 2021;57:473–80, <http://dx.doi.org/10.1111/ppc.12651>.
- Kisorio LC, Langley GC. End-of-life care in intensive care unit: Family experiences. *Intensive Crit Care Nurs*. 2016;35:57–65, <http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2016.03.003>.
- Momeni G, Hashemi MS, Hemati Z. Barriers to Providing Spiritual Care from a Nurses' Perspective: A Content Analysis Study. *Iran J Nurs Midwifery Res*. 2022;27:575–80, <http://dx.doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr.422.21>.
- Wang Z, Yang Y, Zhu Y, Liu M, Zhao X, Xiao L, et al. Spiritual care needs among Chinese elders hospitalized for severe chronic heart failure: An observational study. *Palliat Support Care*. 2023;21:108–17, <http://dx.doi.org/10.1017/S1478951522001237>.
- Maleki M, Mardani A, Harding C, Basirinezhad MH, Vaismoradi M. Nurses' strategies to provide emotional and practical support to the mothers of preterm infants in the neonatal intensive care unit: A systematic review and meta-analysis. *Womens Health (Lond)*. 2022;18, <http://dx.doi.org/10.1177/17455057221104674>.
- Asadi Z, Jackson AC, Moradpour F, Cheraghi MA, Sharifi F, Bahramnezhad F. Investigating the Relationship Between Spiritual Health, Meaning in Life, and Death Attitudes among COVID-19 Patients Discharged from ICUs: A Cross-Sectional Study in Iran. *J Relig Health*. 2023;62:2984–96, <http://dx.doi.org/10.1007/s10943-023-01834-3>.
- Casabella-García CA, Pálizas FJ, Solano-Rueda CA, Guantay ME, Garay CD. Cambios en las visitas a cuidados intensivos durante la pandemia COVID-19. *Medicina (B. Aires)*. 2020;80 Suppl 6:119–20 [consultado 2023 Oct 17] Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802020001000119&lng=e
- Fernández-Castillo RJ, González-Caro MD, Arroyo-Muñoz FJ, Garnacho-Montero J. National survey on changes in visitation, communication and end-of-life care policies in intensive care units through the different COVID-19 pandemic's waves (COVIFAUCI study). *Enferm Intensiva (Engl Ed)*. 2023;S2529–9840:00041–51, <http://dx.doi.org/10.1016/j.enfie.2023.07.004>.
- Meneguín S, Pollo CF, Benichel CR, Cunha LK, Miot HA. Comfort and religious-spiritual coping of intensive care patients' relatives. *Intensive Crit Care Nurs*. 2020;58:102805, <http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102805>.
- Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). *JBIM Manual for Evidence Synthesis*, JBI, 2020 [consultado 23 Oct 2023]. Disponible en: <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12>
- About JBI (no date) JBI [consultado 24 Oct 2023] Disponible en: <https://jbi.global/about-jbi>
- Kappes M, Catalan L, Fernandez C. Spirituality in nursing care at ICU: Scoping review. *OSF*. 2023 [consultado 23 Oct 2023] Disponible en: <http://osf.io/wghzr>
- Villacreses Merino KM, Bravo Gutiérrez GN, Zambrano Lucas ES, Tigse Tubay LJ. Atención humanizada en UCI. *RECIMUNDO*. 2023;7:261–71, [http://dx.doi.org/10.26820/recimundo/7.\(4\).oct.2023.261-271](http://dx.doi.org/10.26820/recimundo/7.(4).oct.2023.261-271).
- Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Ann Intern Med*. 2018;169:467–73.
- De Diego-Cordero R, Rey-Reyes A, Vega-Escano J, Lucchetti G, Badanta B. Spiritual needs during COVID 19 pande-

- mic in the perceptions of Spanish emergency critical care health professionals. *Intensive Crit Care Nurs.* 2023;76:103373, <http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2022.103373>.
23. Asamrew N, Endris AA, Tadesse M. Level of Patient Satisfaction with Inpatient Services and Its Determinants: A Study of a Specialized Hospital in Ethiopia. *J Environ Public Health.* 2020;2020:2473469, <http://dx.doi.org/10.1155/2020/2473469>.
 24. Elham H, Hazrati M, Momennasab M, Sareh K. The effect of need-based spiritual/religious intervention on spiritual well-being and anxiety of elderly people. *Holist Nurs Pract.* 2015;29:136–43, <http://dx.doi.org/10.1097/HNP.0000000000000083>.
 25. Roze des Ordon AL, Stelfox HT, Sinuff T, Grindrod-Millar K, Sinclair S. Exploring spiritual health practitioners' roles and activities in critical care contexts. *J Health Care Chaplain.* 2022;28:41–62, <http://dx.doi.org/10.1080/08854726.2020.1734371>.
 26. Zambezi M, Emmamally W, Mooi N. Spiritual Care: A Description of Family Members' Preferences of Spiritual Care Nursing Practices in Intensive Care Units in a Private Hospital in Kwa-Zulu Natal, South Africa. *Healthcare (Basel).* 2022;10:595, <http://dx.doi.org/10.3390/healthcare10040595>.
 27. Coughlin K, Mackley A, Kwadu R, Shanks V, Sturtz W, Munson D, et al. Characterization of Spirituality in Maternal-Child Caregivers. *J Palliat Med.* 2017;20:994–7, <http://dx.doi.org/10.1089/jpm.2016.0361>.
 28. Willemse S, Smeets W, van Leeuwen E, Janssen L, Foudraïne N. Spiritual Care in the ICU: Perspectives of Dutch Intensivists, ICU Nurses, and Spiritual Caregivers. *J Relig Health.* 2018;57:583–95, <http://dx.doi.org/10.1007/s10943-017-0457-2>.
 29. Milner KA, Marmo S, Goncalves S. Implementation and sustainment strategies for open visitation in the intensive care unit: A multicentre qualitative study. *Intensive Crit Care Nurs.* 2021 Feb;62:102927, <http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102927>.
 30. Xie W, Chen L, Feng F, Okoli CTC, Tang P, Zeng L, et al. The prevalence of compassion satisfaction and compassion fatigue among nurses: A systematic review and meta-analysis. *Int J Nurs Stud.* 2021;120:103973, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.103973>.
 31. Palmeira AFA, Lopes CT, Neves VR. Nursing professionals' education on the spiritual dimension of critical patients [Article in English, Portuguese]. *Rev Gaucha Enferm.* 2023;44:e20220069.
 32. Green J, Berdahl CT, Ye X, Wertheimer JC. The impact of positive reinforcement on teamwork climate, resiliency, and burnout during the COVID-19 pandemic: The TEAM-ICU (Transforming Employee Attitudes via Messaging strengthens Interconnection, Communication, and Unity) pilot study. *J Health Psychol.* 2023;28:267–78, <http://dx.doi.org/10.1177/13591053221103640>.
 33. Paraiso-Pueyo E, González-Alonso AV, Botigué T, Masot O, Escobar-Bravo MÁ, Lavedán-Santamaría A. Nursing interventions for perinatal bereavement care in neonatal intensive care units: A scoping review. *Int Nurs Rev.* 2021;68:122–37, <http://dx.doi.org/10.1111/inr.12659>.
 34. Umbrello M, Sorrenti T, Mistraletti G, Formenti P, Chiumello D, Terzoni S. Music therapy reduces stress and anxiety in critically ill patients: A systematic review of randomized clinical trials. *Minerva Anesthesiol.* 2019;85:886–98, <http://dx.doi.org/10.23736/S0375-9393.19.13526-2>.
 35. Caulfield FM, Ihidero OA, Carroll M, Dunworth M, Hunt M, McAuliffe D, et al. Spiritual care in neonatology: Analysis of emergency baptisms in an Irish neonatal unit over 15 years. *Ir J Med Sci.* 2019;188:607–12, <http://dx.doi.org/10.1007/s11845-018-1894-y>.
 36. Noome M, Beneken Genaamd Kolmer DM, van Leeuwen E, Dijkstra BM, Vloet LCM. The role of ICU nurses in the spiritual aspects of end-of-life care in the ICU: An explorative study. *Scand J Caring Sci.* 2017;31:569–78, <http://dx.doi.org/10.1111/scs.12371>.
 37. Bulut TY, Çekiç Y, Altay B. The effects of spiritual care intervention on spiritual well-being, loneliness, hope and life satisfaction of intensive care unit patients. *Intensive Crit Care Nurs.* 2023;77:103438, <http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2023.103438>.